

Uretritis, cervicitis y úlcera genital

Diagnóstico diferencial y tratamiento empírico · La ceftriaxona cambió de dosis · Notificación, parejas y tamizaje asociado

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: ITS: infección de transmisión sexual · TAAN: test de amplificación de ácidos nucleicos · EPI: enfermedad inflamatoria pelviana · VHS: virus herpes simplex · LGV: linfogranuloma venéreo · HSH: hombres que tienen sexo con hombres · PrEP/PEP: profilaxis preexposición / postexposición · VDRL/RPR: pruebas no treponémicas · MHA-TP/FTA-ABS: pruebas treponémicas · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las *Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines* de los CDC (2021) y sus actualizaciones, las guías de la OMS, y la normativa chilena de manejo de las ITS del MINSAL. **Las ITS son de notificación obligatoria en Chile y la norma nacional define el flujo de manejo, notificación y estudio de contactos: verificar la versión vigente en www.minsal.cl.**

Índice

1. Principios generales del manejo de las ITS
2. Uretritis en el hombre
3. Cervicitis en la mujer
4. Diagnóstico microbiológico
5. Tratamiento de la uretritis y la cervicitis
6. Uretritis persistente o recurrente
7. Enfermedad inflamatoria pelviana
8. Úlcera genital: el diagnóstico diferencial
9. Herpes genital
10. Sífilis primaria
11. Chancroide, linfogranuloma venéreo y donovanosis
12. Causas no infecciosas de úlcera genital
13. Manejo de parejas, notificación y tamizaje asociado
14. Prevención
15. Errores frecuentes
16. Perlas de alto rendimiento
17. Bibliografía esencial

1. Principios generales del manejo de las ITS

Los seis principios que se aplican a toda consulta por ITS: 1. **Tratar empíricamente en la primera consulta**, sin esperar resultados: la pérdida de seguimiento es alta y la transmisión continúa. 2. **Tamizar simultáneamente para las demás ITS: VIH, sífilis, hepatitis B y C**, y las que correspondan según la práctica sexual. 3. **Tratar a las parejas sexuales** de los últimos 60 días (o a la última pareja si el contacto fue anterior). 4. **Indicar abstinencia sexual** hasta 7 días después de completar el tratamiento del paciente y de sus parejas, y hasta la resolución de los síntomas. 5. **Notificar** según la normativa nacional. 6. **Ofrecer prevención:** vacunación (hepatitis B, virus papiloma humano), preservativo, **PrEP** en personas con indicación.

Una nota sobre el lenguaje: la consulta por ITS es un espacio de alta carga de estigma. El uso de un lenguaje neutro, no juzgador y centrado en la persona —y la garantía explícita de confidencialidad— **mejora la revelación de información y la adherencia**, y es parte del estándar de atención.

2. Uretritis en el hombre

Definición: inflamación uretral con **descarga**, disuria o prurito uretral.

	Uretritis gonocócica	Uretritis no gonocócica
Agente	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<i>Chlamydia trachomatis</i> (15-40 %), <i>Mycoplasma genitalium</i> (15-25 %), <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , adenovirus, VHS
Incubación	2-7 días	1-5 semanas
Descarga	Abundante, francamente purulenta	Escasa, mucóide o clara, a menudo matinal
Síntomas	Disuria intensa	Disuria leve, prurito

La distinción clínica no es fiable, y las coinfecciones son frecuentes: por eso el tratamiento empírico ha cubierto históricamente ambos agentes.

Diagnóstico sindrómico: ≥ 2 leucocitos por campo de inmersión en el Gram del exudado uretral, o ≥ 10 leucocitos por campo en el sedimento de la primera orina, o esterasa leucocitaria positiva. **El Gram con diplococos gramnegativos intracelulares es diagnóstico de gonorrea en el hombre sintomático** (sensibilidad $> 95\%$, especificidad $> 99\%$); **en la mujer y en muestras faríngeas o rectales, el Gram no es fiable.**

3. Cervicitis en la mujer

Definición: inflamación cervical con **exudado mucopurulento endocervical** o **sangrado fácil al roce del cuello** ("friabilidad").

- **Con frecuencia es asintomática**, lo que explica que la infección por *Chlamydia* se diagnostique tarde y progrese a EPI e infertilidad tubaria.
- **Agentes:** *C. trachomatis*, *N. gonorrhoeae*, *M. genitalium*, *T. vaginalis*, VHS. **En más de la mitad de los casos no se identifica agente.**
- **Diferencial:** vaginosis bacteriana, candidiasis, tricomoniasis, vaginitis atrófica, cuerpo extraño, irritantes químicos.
- **Toda cervicitis obliga a descartar EPI** mediante examen bimanual: dolor a la movilización cervical, dolor uterino o anexial.

4. Diagnóstico microbiológico

Prueba	Comentario
TAAN (biología molecular) para <i>N. gonorrhoeae</i> y <i>C. trachomatis</i>	Método de elección. Muestra: primera orina en el hombre, hisopado vaginal o endocervical en la mujer. Muy importante: en personas con exposición oral o anal, hay que tomar muestras faríngeas y rectales , porque la mayoría de esas infecciones son asintomáticas y no se detectan con muestra genital
TAAN para <i>M. genitalium</i>	Disponible en algunos centros; indicado en uretritis o cervicitis persistente o recurrente
TAAN o cultivo para <i>T. vaginalis</i>	El TAAN es más sensible que el examen en fresco
Cultivo de <i>N. gonorrhoeae</i>	Menos sensible que el TAAN, pero es el único que entrega susceptibilidad : mantiene su valor para la vigilancia de resistencia y en casos de fracaso terapéutico
Gram del exudado uretral	Rápido y útil en el hombre sintomático
Serología	VIH, sífilis (VDRL/RPR y prueba treponémica), hepatitis B y C en toda consulta por ITS

5. Tratamiento de la uretritis y la cervicitis

El cambio más importante de los últimos años es el aumento de la dosis de ceftriaxona y el abandono del cotratamiento sistemático con azitromicina, por la resistencia creciente del gonococo.

Situación	Tratamiento (CDC 2021)
Gonorrea no complicada (uretral, cervical, rectal o faríngea)	Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única (1 g si el peso es ≥ 150 kg). Si la infección por <i>Chlamydia</i> no ha sido descartada, agregar doxiciclina 100 mg VO cada 12 h por 7 días

Situación	Tratamiento (CDC 2021)
<i>Chlamydia trachomatis</i>	Doxiciclina 100 mg VO cada 12 h por 7 días — ha desplazado a la azitromicina por su mayor eficacia, sobre todo en la infección rectal. Alternativa: azitromicina 1 g VO dosis única (de elección en el embarazo)
<i>Mycoplasma genitalium</i>	Tratamiento en dos pasos guiado por resistencia a macrólidos: doxiciclina 7 días seguida de azitromicina (si es sensible) o de moxifloxacino 400 mg/día por 7 días (si es resistente o no se conoce)
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Mujeres: metronidazol 500 mg VO cada 12 h por 7 días. Hombres: metronidazol 2 g VO dosis única. Tratar siempre a la pareja
Alergia grave a cefalosporinas (gonorrea)	Gentamicina 240 mg IM más azitromicina 2 g VO , o alternativas según la guía vigente. Consultar con infectología
Embarazo	Ceftriaxona igual; para <i>Chlamydia</i> , azitromicina 1 g dosis única (la doxiciclina está contraindicada)

Puntos clave:

- **La azitromicina ya no acompaña sistemáticamente a la ceftriaxona** en el tratamiento de la gonorrea: se agrega **doxiciclina** sólo si no se ha descartado *Chlamydia*.
- **La resistencia del gonococo es un problema global creciente** (quinolonas, macrólidos, y con reportes de sensibilidad reducida a cefalosporinas): por eso se mantiene la vigilancia con cultivo y la notificación de los fracasos terapéuticos.
- **Prueba de curación:** no se requiere de rutina en la infección genital, pero **sí en la gonorrea faríngea** (a las 7-14 días) y ante persistencia de síntomas o duda de adherencia.
- **Retamizaje a los 3 meses:** recomendado tras una gonorrea o clamidia, por la alta tasa de reinfección.

6. Uretritis persistente o recurrente

Ante síntomas que persisten o recurren tras el tratamiento:

1. **Descartar reexposición:** pareja no tratada o nueva pareja — la causa más frecuente.
2. **Verificar la adherencia** al tratamiento.
3. **Estudiar *Mycoplasma genitalium*** con TAAN y, si está disponible, **estudio de resistencia a macrólidos**.
4. **Estudiar *Trichomonas vaginalis*** con TAAN.
5. **Considerar causas no infecciosas:** irritación química, traumatismo, uretritis por cuerpo extraño.
6. **Derivar a urología o infectología** si persiste tras un manejo adecuado.

7. Enfermedad inflamatoria pelviana

- **Sospecha:** mujer sexualmente activa con **dolor pelviano o abdominal bajo** más **dolor a la movilización cervical, dolor uterino o dolor anexial** al examen bimanual. **Los criterios diagnósticos son deliberadamente laxos**, porque el costo de no tratar (infertilidad, embarazo ectópico, dolor pelviano crónico) es mucho mayor que el de tratar de más.
- **Agentes:** *N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*, *M. genitalium*, y **flora vaginal mixta con anaerobios**.
- **Tratamiento ambulatorio:** ceftriaxona 500 mg IM dosis única + **doxiciclina 100 mg cada 12 h por 14 días + metronidazol 500 mg cada 12 h por 14 días**.
- **Criterios de hospitalización:** embarazo, **absceso tuboovárico**, incapacidad de tolerar la vía oral, enfermedad grave con fiebre alta y compromiso del estado general, sospecha de urgencia quirúrgica (apendicitis, embarazo ectópico), o fracaso del tratamiento ambulatorio.
- **Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis:** perihepatitis con dolor en hipocondrio derecho, asociada a EPI por *Chlamydia* o gonococo.

8. Úlcera genital: el diagnóstico diferencial

Causa	Lesión	Dolor	Adenopatías	Diagnóstico
Herpes genital (VHS-1 y 2)	Vesículas agrupadas que se ulceran; múltiples, superficiales, de base eritematosa	Muy doloroso	Bilaterales, dolorosas	PCR de la lesión (de elección); cultivo viral; serología tipo-específica

Causa	Lesión	Dolor	Adenopatías	Diagnóstico
<i>Sífilis primaria (T. pallidum)**</i>	Chancro: úlcera ÚNICA, de bordes indurados, fondo limpio, base dura	Indoloro	Bilaterales, indoloras , no supurativas	VDRL/RPR + prueba treponémica ; campo oscuro donde esté disponible
<i>Chancroide (Haemophilus ducreyi)**</i>	Úlceras múltiples, profundas, de bordes irregulares y socavados, fondo sucio y purulento, base blanda	Muy doloroso	Unilaterales, fluctuantes, supurativas (bubón)	Cultivo en medio especial (poco disponible); PCR; diagnóstico habitualmente clínico y de exclusión
<i>Linfogranuloma venéreo (C. trachomatis L1-L3)**</i>	Úlcera pequeña y transitoria que suele pasar desapercibida	Indolora	Adenopatía inguinal marcada y dolorosa (bubón) , "signo del surco". En HSH, proctocolitis	TAAN para <i>Chlamydia</i> con genotipificación
<i>Donovanosis (Klebsiella granulomatis)**</i>	Úlceras " en carne viva ", muy vascularizadas, que sangran fácilmente, de crecimiento lento	Indolora	Ausentes (pseudobubón por granulación)	Cuerpos de Donovan en el frotis o biopsia. Muy infrecuente fuera de zonas endémicas

La regla mnemotécnica que ordena el diferencial Úlcera única e indolora con base indurada = SÍFILIS. Úlceras múltiples y muy dolorosas, con vesículas previas = HERPES. Úlceras dolorosas con bubón supurativo = CHANCROIDE. Bubón desproporcionado con úlcera mínima = LINFOGRANULOMA VENÉREO.

Pero: las presentaciones atípicas son frecuentes, la coinfección existe, y **hasta un cuarto de las úlceras genitales queda sin diagnóstico etiológico**. Por eso, ante una úlcera genital, el estándar es **estudiar herpes y sífilis en todos los casos y tratar empíricamente** cuando el seguimiento no está asegurado.

En Chile, el herpes genital y la sífilis primaria explican la gran mayoría de las úlceras genitales; el chancroide, el linfogranuloma venéreo y la donovanosis son raros, aunque el LGV ha resurgido en algunos países como proctitis en HSH.

9. Herpes genital

- **Agentes:** VHS-2 clásicamente, pero **VHS-1 es hoy causa creciente de herpes genital primario**, sobre todo en personas jóvenes, por transmisión orogenital.
- **Primoinfección:** lesiones extensas y muy dolorosas, fiebre, malestar, adenopatías, disuria, retención urinaria; puede haber meningitis aséptica.
- **Recurrencias:** más leves y breves, con pródromo de ardor o parestesia; más frecuentes con VHS-2.
- **Diagnóstico:** **PCR de la lesión** es el método de elección. La **serología tipo-específica** (glicoproteína G) permite distinguir VHS-1 de VHS-2 y es útil para el diagnóstico en pacientes con historia sugerente y lesiones no activas, o para evaluar a la pareja; **no se recomienda el tamizaje serológico poblacional**.
- **Tratamiento:**

Situación	Esquema
Primer episodio	Valaciclovir 1 g VO cada 12 h por 7-10 días (o aciclovir 400 mg cada 8 h)
Recurrencia	Valaciclovir 500 mg cada 12 h por 3 días, o 1 g/día por 5 días — iniciado en el pródromo o en las primeras 24 h
Terapia supresora (>= 4-6 recurrencias al año, o para reducir la transmisión a la pareja)	Valaciclovir 500 mg-1 g/día
Embarazo	Supresión desde la semana 36 en mujeres con herpes genital recurrente, para reducir la necesidad de cesárea y el riesgo de herpes neonatal

- **La terapia supresora reduce la transmisión a la pareja**, pero no la elimina: el preservativo y la abstinencia durante los brotes siguen siendo necesarios.
- **Toda úlcera genital obliga a ofrecer estudio de VIH:** el herpes aumenta el riesgo de transmisión y adquisición del VIH.
- **En el paciente con VIH avanzado**, las lesiones pueden ser extensas, crónicas y resistentes a aciclovir (por deficiencia de timidina quinasa): **tratamiento con foscarnet**.

10. Sífilis primaria

- **Chancro:** úlcera única, indolora, de base indurada y fondo limpio, que aparece 10-90 días (media 21) tras la exposición, y cicatriza espontáneamente en 3-6 semanas aunque no se trate — lo que hace que muchos pacientes no consulten y progresen a la etapa secundaria.
- Puede ser **extragenital** (oral, anal) y pasar desapercibido, particularmente en HSH.
- **Diagnóstico:** prueba no treponémica (VDRL o RPR) más prueba treponémica. En la sífilis primaria muy precoz la serología puede ser todavía negativa: si la sospecha es alta, tratar y repetir la serología en 2-4 semanas.
- **Tratamiento:** penicilina G benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única.
- Desarrollo completo en el documento de Sífilis y neurosífilis.

11. Chancroide, linfogranuloma venéreo y donovanosis

Entidad	Tratamiento
Chancroide	Azitromicina 1 g VO dosis única, o ceftriaxona 250 mg IM dosis única, o ciprofloxacino 500 mg cada 12 h por 3 días, o eritromicina. Aspirar el bubón fluctuante si es necesario
Linfogranuloma venéreo	Doxiciclina 100 mg cada 12 h por 21 días (nótese la duración prolongada). Alternativa: azitromicina 1 g semanal por 3 semanas
Donovanosis	Azitromicina 1 g semanal por >= 3 semanas y hasta la cicatrización completa

12. Causas no infecciosas de úlcera genital

Deben considerarse cuando el estudio es negativo o el cuadro es atípico:

- **Enfermedad de Behçet** (aftas orales y genitales recurrentes, uveítis, patergia).
- **Aftosis genital compleja, úlcera de Lipschütz** (mujer joven, tras cuadro viral, no ITS).
- **Erupción fija por fármacos**, síndrome de Stevens-Johnson.
- **Enfermedad de Crohn** con compromiso perineal.
- **Liquen plano, liquen escleroso, penfigoide.**
- **Neoplasia:** carcinoma escamoso, especialmente en lesiones que no cicatrizan.
- **Trauma.**

Una úlcera genital que no cicatriza en 4-6 semanas pese a tratamiento adecuado requiere biopsia.

13. Manejo de parejas, notificación y tamizaje asociado

- Tratar a las parejas sexuales de los últimos 60 días (o a la última pareja, si el contacto fue anterior), **aunque estén asintomáticas y sin esperar sus resultados.** - **Abstinencia sexual** hasta 7 días después de completar el tratamiento de ambos y hasta la resolución de los síntomas. - **Tamizar siempre para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C.** En personas con exposición oral o anal, tomar **muestras faríngeas y rectales** para gonococo y clamidia. - **Notificación obligatoria** de las ITS según el decreto vigente del MINSAL, con la **confidencialidad** que la ley exige. La sífilis y el VIH tienen normas específicas de notificación y de estudio de contactos. - **En la embarazada**, el tamizaje de sífilis y VIH está normado y es obligatorio; la sífilis gestacional y congénita son de notificación inmediata. - **Ofrecer vacunación** contra hepatitis B y contra virus papiloma humano según la indicación vigente, y **evaluar indicación de PrEP.**

14. Prevención

- **Preservativo** en todas las relaciones, incluidas las orales y anales.
- **Vacunación:** hepatitis B, virus papiloma humano, y hepatitis A en poblaciones de riesgo.
- **PrEP** para VIH en personas con indicación (ver documento específico).
- **Tamizaje periódico** en poblaciones de mayor riesgo: HSH, personas con múltiples parejas, personas con VIH, personas en PrEP, trabajadoras y trabajadores sexuales.
- **Educación y consejería** en la consulta, sin juicio y con lenguaje respetuoso.

15. Errores frecuentes

- **No tratar empíricamente** en la primera consulta, esperando resultados. - **No tomar muestras faríngeas y rectales** en personas con esas exposiciones: la mayoría de esas infecciones son asintomáticas. - **Seguir usando ceftriaxona 250 mg** para la gonorrea: la dosis actual es **500 mg**. - **Agregar azitromicina de rutina** a la ceftriaxona: hoy se agrega **doxiciclina** y sólo si no se descartó *Chlamydia*. - **Usar azitromicina como primera línea para Chlamydia**: la doxiciclina es superior. - **No tratar a las parejas**. - **No tamizar VIH, sífilis y hepatitis** en toda consulta por ITS. - **Descartar sífilis por una serología negativa** en un chancro muy precoz. - **No pensar en EPI** ante una cervicitis, omitiendo el examen bimanual. - **No biopsiar** una úlcera genital que no cicatriza. - **No notificar** ni respetar la confidencialidad exigida por la norma.

16. Perlas de alto rendimiento

- **Tratar empíricamente en la primera consulta y tratar a las parejas.**
- **Gonorrea: ceftriaxona 500 mg IM dosis única** (1 g si ≥ 150 kg); agregar **doxiciclina 7 días** si no se descartó *Chlamydia*.
- **Chlamydia: doxiciclina 7 días** (azitromicina 1 g en el embarazo).
- **El Gram con diplococos gramnegativos intracelulares diagnostica gonorrea en el hombre sintomático**, pero no sirve en muestras cervicales, faríngeas ni rectales.
- **Tomar muestras según la práctica sexual**: faríngea y rectal, o se pierden la mayoría de las infecciones.
- **Uretritis persistente** -> **pensar en *M. genitalium* y en *T. vaginalis***, y descartar reexposición.
- **Úlcera única e indolora e indurada = sífilis. Múltiples y dolorosas = herpes. Bubón supurativo = chancroide. Bubón desproporcionado = LGV.**
- **Ante toda úlcera genital: estudiar herpes y sífilis, y ofrecer estudio de VIH.**
- **La serología de sífilis puede ser negativa en el chancro precoz**: tratar y repetir.
- **EPI: los criterios son laxos a propósito**; el costo de no tratar es la infertilidad.
- **Linfogranuloma venéreo: doxiciclina 21 días.**
- **Una úlcera genital que no cicatriza en 4-6 semanas se biopsia.**

17. Bibliografía esencial

- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187.
- Centers for Disease Control and Prevention. Update to CDC's treatment guidelines for gonococcal infection, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69:1911-6.
- World Health Organization. *Guidelines for the management of symptomatic sexually transmitted infections*. 2021.
- Geisler WM, Uniyal A, Lee JY, et al. Azithromycin versus doxycycline for urogenital *Chlamydia trachomatis* infection. *N Engl J Med*. 2015;373:2512-21.
- Ministerio de Salud de Chile. Normas de manejo y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Verificar la versión vigente en www.minsal.cl.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Vigilancia de resistencia de *Neisseria gonorrhoeae*. Disponible en www.ispch.cl.